

**DOTT.SSA CLAUDIA SPOSINI**

Psicoterapeuta e Consulente Sessuale



# Quando la Testa Blocca il Corpo

Guida clinica sull'ansia da prestazione sessuale maschile

*Cosa succede davvero nel tuo corpo — e il primo passo per uscirne*

**PSICOTERAPIA • CONSULENZA SESSUALE • BENESSERE MASCHILE**

Guida ad uso personale — non sostituisce la consulenza clinica individuale

Copyright 2025 Dott.ssa Claudia Sposini. Tutti i diritti riservati.

Vietata la riproduzione, copia o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta.

## NOTA DELL'AUTORE

*Negli anni di lavoro clinico con pazienti di sesso maschile, una cosa mi ha colpito con costanza: quanti uomini portano questo problema in silenzio. Convinti di essere gli unici. Convinti che ci sia qualcosa di fondamentalmente sbagliato in loro.*

*Nessuno ne parla. Non con gli amici, non con il medico, non con la partner. C'è un muro invisibile attorno a questo argomento, costruito di vergogna e aspettative impossibili. E quel silenzio, quasi sempre, peggiora le cose.*



*Ho scritto questa guida per abbattere quel muro. Non è un testo accademico, non è una raccolta di tecniche generiche. È quello che spiego ai miei pazienti durante i percorsi clinici individuali — con la stessa chiarezza e lo stesso rispetto che merita chi ha il coraggio di chiedere aiuto.*

*Buona lettura.*

**Dott.ssa Claudia Sposini**

Psicoterapeuta e Consulente Sessuale



SOMMARIO

# Cosa trovi in questa guida

---

|           |                                                                                                          |           |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | <b>Non sei l'unico</b><br>La scena che conosci. Il grande silenzio maschile. I dati clinici.             | <b>3</b>  |
| <b>02</b> | <b>Cosa succede davvero</b><br>Sistema nervoso, meccanismo mente-corpo e ciclo ansioso.                  | <b>5</b>  |
| <b>03</b> | <b>Scenari clinici tipici</b><br>Quattro profili rappresentativi di presentazione clinica.               | <b>8</b>  |
| <b>04</b> | <b>Il fraintendimento più comune</b><br>Come il problema viene vissuto — e le direzioni reali di lavoro. | <b>9</b>  |
| <b>05</b> | <b>Il passo successivo</b><br>Capire non basta. Come il cambiamento reale diventa possibile.             | <b>11</b> |

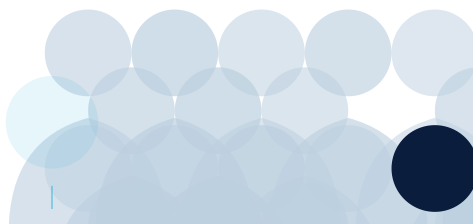
---

## SEZIONE 01

# Non sei l'unico

---

*Il primo passo non è trovare la soluzione. È capire che non sei solo.*



Sono le undici di sera. Hai aspettato questo momento per settimane. Lei è lì, c'è desiderio, c'è attesa — tutto sembra perfetto. Poi qualcosa si blocca. Il corpo non risponde come dovrebbe. Un silenzio di pochi secondi che sembra durare un'ora. Lei dice che va bene, che non importa. Ma tu ci pensi per giorni. E la prossima volta ci pensi ancora prima che succeda.

Quella sensazione — quel misto di vergogna, paura e incomprensione — è quello che porta migliaia di uomini a cercare risposte in silenzio, di notte, in modalità incognito, senza dirlo a nessuno.



## Il grande silenzio maschile

L'identità maschile è ancora costruita, in larga parte, attorno alla performance: forza, controllo, disponibilità. Un uomo che vive difficoltà in camera da letto sente spesso di aver tradito qualcosa di fondamentale in sé stesso.

Così non ne parla. Non con gli amici — sarebbe ammettere una debolezza in un contesto dove la virilità è ancora una gara non dichiarata. Non con il medico — perché sembra troppo poco per un appuntamento, o forse troppo imbarazzante. Non con la partner — per paura di sembrare meno.

Il risultato è che un problema trattabile rimane congelato nel silenzio e diventa, nel tempo, sempre più grande.



#### Dato clinico di riferimento

Studi sulla sessualità maschile indicano che l'ansia da prestazione è una delle difficoltà più diffuse, con una prevalenza significativa e picchi nella fascia tra i 25 e i 40 anni.

### Tu non sei un'eccezione

L'ansia da prestazione è uno dei disturbi sessuali più comuni nell'uomo. Capita alla prima notte con una nuova partner. Capita dopo mesi di stress lavorativo. Capita dopo una separazione, o dopo una singola serata storta che lascia il segno.

Non è un segnale che qualcosa non vada bene in te. È un segnale che il tuo sistema nervoso sta reagendo esattamente come è programmato per fare — nel momento sbagliato, per le ragioni sbagliate. Tra poco capirai esattamente come.

### La pressione invisibile del confronto

Viviamo in un'epoca di iperstimolazione sessuale. Il porno è accessibile a chiunque con standard di performance completamente irrealistici. I social mostrano corpi e relazioni senza intoppi. Il risultato è una generazione di uomini che si confronta — inconsciamente, costantemente — con un'asticella che nessuno nella realtà può raggiungere.

Questo confronto non crea sicurezza. Crea ansia. E l'ansia, come vedrai, è il peggior nemico fisiologico della risposta sessuale.

*Questa guida non ti dirà di rilassarti o di non pensarci. Ti dirà cosa sta succedendo davvero nel tuo corpo e nella tua testa — con precisione. E ti mostrerà che esiste una direzione concreta in cui andare.*

## SEZIONE 02

# Cosa succede davvero

*Il meccanismo che nessuno ti ha mai spiegato — e che cambia tutto.*

## Il sistema nervoso: il vero protagonista

### SISTEMA SIMPATICO

#### Allarme

*"Combatti o fuggi"*

- ↑ Battito cardiaco accelerato
- ↑ Adrenalina e cortisolo
- ↓ Vasocostrizione (flusso ridotto)
- ↑ Tensione muscolare



### SISTEMA PARASIMPATICO

#### Piacere

*"Riposo e risposta erotica"*

- ↓ Battito cardiaco rallentato
- ↑ Vasodilatazione (flusso aumentato)
- ↓ Rilassamento muscolare
- ✓ Risposta erotica possibile



⇒ **ANTAGONISMO DIRETTO: L'UNO SPEGNE L'ALTRO**

Il sistema nervoso autonomo ha due rami principali. Il **sistema simpatico** è il tuo sistema di allarme: si attiva quando percepisci una minaccia — fisica o psicologica. Il **sistema parasimpatico** è il tuo sistema di riposo e piacere: si attiva quando ti senti al sicuro. Ed è esattamente il sistema che rende possibile l'erezione.

### Il punto fisiologico chiave

L'erezione richiede vasodilatazione e aumento del flusso ematico nei corpi cavernosi. Questo processo dipende interamente dall'attivazione parasimpatica. L'ansia attiva il simpatico. I due sistemi sono in antagonismo diretto. **Ansia ed erezione sono fisiologicamente incompatibili.** Non è un difetto — è anatomia.

Quando ti avvicini a un momento intimo con la paura di non essere all'altezza, il cervello registra quella situazione come una minaccia. Attiva il simpatico. E il simpatico fa esattamente ciò per cui è programmato: proteggerti. Il problema è che quella protezione, in camera da letto, è l'ultima cosa di cui hai bisogno.

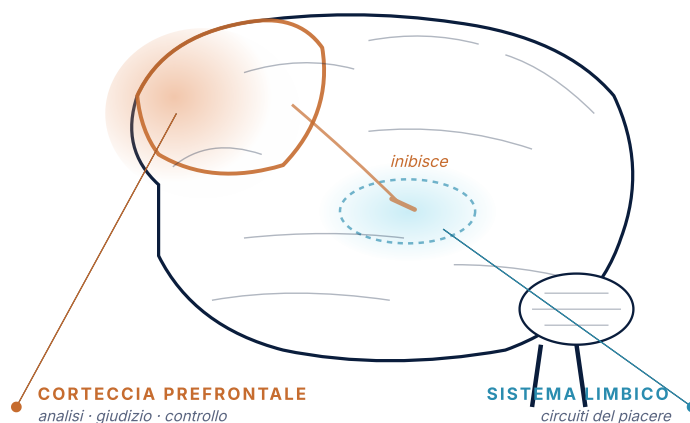
## Il problema dei pensieri durante il sesso

Nel 1970 Masters e Johnson descrissero un fenomeno chiamato *spectatoring*: l'uomo ansioso si sdoppia durante il rapporto. Una parte partecipa — fisicamente presente, desiderante. L'altra lo osserva dall'esterno e lo valuta: *sto andando bene? durerò abbastanza? cosa sta pensando lei?*



*Lo sdoppiamento: una parte è nell'esperienza, l'altra la osserva e la giudica.*

Questo sdoppiamento ha un costo enorme. I pensieri valutativi attivano la **corteccia prefrontale** — la parte del cervello che analizza, pianifica, giudica — e quella corteccia inibisce i circuiti del piacere. In termini pratici: più ci pensi, meno funziona.



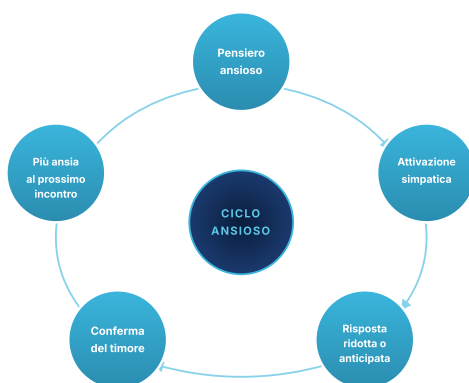
*Quando la prefrontale è iperattiva, i circuiti del piacere vengono frenati.*

C'è poi una distinzione che pochi conoscono: **eccitazione mentale** (il desiderio) e **risposta corporea** (l'erezione) non sono la stessa cosa. Puoi desiderare intensamente e non averla — questo non dice nulla sulla tua attrazione. Dice solo che il sistema nervoso è in modalità allarme.

## L'eiaculazione precoce e il ruolo dell'ansia

Lo stesso meccanismo spiega l'eiaculazione precoce. L'iperattivazione simpatica non blocca solo l'erezione — in certi casi la accelera verso la fine: tensione muscolare aumentata, soglia di eccitazione abbassata, risposta eiaculatoria anticipata. Il ciclo è preciso nella sua logica: preoccupazione prima del rapporto → tensione muscolare e mentale → eiaculazione anticipata → più preoccupazione al prossimo incontro. Non si risolve con più esperienza, né con più autocontrollo, né aspettando. Si risolve interrompendo il ciclo.

### Il ciclo che si autoalimenta



*Il ciclo è autosostenuto. Ogni ripetizione lo consolida. Non si spezza con la forza di volontà — si spezza con un intervento mirato.*

### Cosa NON è l'ansia da prestazione

- Non è impotenza organica — quella ha cause fisiche distinte e richiede valutazione specifica.
- Non significa non essere attratti dalla partner — desiderio e risposta corporea sono processi separati.
- Non è un disturbo mentale grave — è una risposta condizionata del sistema nervoso.
- + È una risposta modificabile con il percorso clinico corretto.
- + Non è colpa tua — nessuno sceglie consapevolmente questo ciclo.



## SEZIONE 03

# Scenari clinici tipici

Quattro profili rappresentativi delle presentazioni più frequenti.

**Nota metodologica:** Gli scenari seguenti sono costruzioni didattiche basate su profili clinici ricorrenti. Non rappresentano persone reali, non sono testimonianze e non costituiscono casi clinici specifici.

## SCENARIO A

**Nuova relazione**

Prima notte dopo una separazione. Alta aspettativa, desiderio presente. Il corpo non risponde. La partner è comprensiva ma lui inizia ad evitare le situazioni intime. L'episodio transitorio si consolida.

Aspettativa elevata + rinforzo negativo da evitamento progressivo.

## SCENARIO B

**Relazione stabile**

Eiaculazione precoce durante un periodo di stress lavorativo intenso. Si ripete. Lui smette di iniziare. Lei interpreta il ritiro come disinteresse. La distanza relazionale amplifica il problema.

Stress cronico predisponente + silenzio come fattore di mantenimento.

## SCENARIO C

**Giovane adulto**

Uso prolungato di pornografia fin dall'adolescenza. Nelle relazioni reali la risposta erotica appare attenuata. Dubbi sulla propria sessualità e sull'attrazione per la partner.

Desensibilizzazione da stimolazione ad alta intensità + confronto distorto.

## SCENARIO D

**Profilo perfezionista**

Il successo professionale porta con sé una mentalità prestazionale. Il sesso diventa un esame da non sbagliare. L'auto-osservazione costante disattiva i circuiti del piacere.

Spectatoring cronico + attivazione prefrontale incompatibile con la risposta erotica.

## SEZIONE 04

# Il fraintendimento più comune

*Quando si vive questa difficoltà, la prima domanda è sempre: "Cosa posso fare?"*

È una domanda comprensibile. Ma spesso porta nella direzione sbagliata. Perché spinge a cercare una soluzione immediata a qualcosa che non nasce a quel livello.

## Come viene vissuto il problema

Molti uomini interpretano quello che succede così:

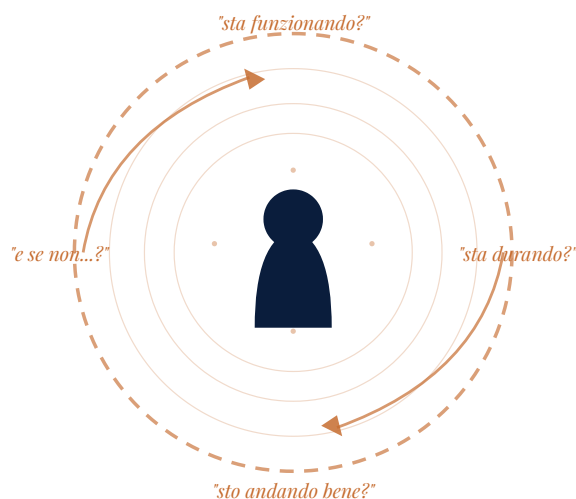
- "non riesco a controllarmi abbastanza"
- "non riesco a mantenere abbastanza l'erezione"
- "non riesco a durare abbastanza"
- "non riesco a essere all'altezza"

Il problema viene vissuto come una mancanza: di controllo, di capacità, di performance.

In realtà, nella maggior parte dei casi, non è questo il punto. Il punto è **come** il tuo sistema mente-corpo entra in quella specifica situazione: questo cambia completamente il tipo di lavoro da fare.

### Non è questione di aggiungere

La reazione più comune è cercare di "aggiungere qualcosa": respirare meglio, controllare i pensieri, gestire il momento. Ma c'è un limite importante: queste cose funzionano solo se il sistema è già in una condizione che le permette. Quando l'attivazione dell'ansia è alta, il corpo non è disponibile a essere regolato in quel modo. E questo crea una sensazione molto frustrante: *"So cosa dovrei fare... ma non riesco a farlo quando serve."*



*La prigione del controllo: ogni domanda di verifica ti porta fuori dall'esperienza e dentro il loop.*

## 02 Cambiare il rapporto con i pensieri

Il problema non è avere pensieri. È il peso che assumono in quel momento. Un pensiero come *"e se non funziona?"* non resta solo un pensiero: il corpo lo vive come un segnale reale e reagisce di conseguenza. Il lavoro non è eliminarli, ma non farsi guidare automaticamente da quelli. E questo non si costruisce nel momento — si costruisce prima.

## 03 Spostare l'attenzione dal risultato all'esperienza

Quando la sessualità diventa orientata a un risultato — *"deve andare così", "devo arrivare lì"* — il corpo entra in modalità prestazione: si osserva, si valuta, si anticipa. Tutte condizioni che allontanano dalla risposta spontanea. Il punto non è fare di meno. È cambiare dove è orientata l'attenzione.

### Perché non si risolve da soli

Queste cose, leggendo, sembrano chiare. Ma il problema non è capirle.

**È riuscire a: riconoscerle mentre succedono, interrompere il meccanismo, non tornare automaticamente negli stessi schemi.**

Ed è qui che molti si fermano. Perché da soli si torna facilmente a quello che il sistema conosce già.



## SEZIONE 05

# Il passo successivo

*Capire è il primo passo. Il cambiamento reale viene dopo.*



Sei arrivato alla fine di questa guida. Hai letto del meccanismo del sistema nervoso, del ciclo ansioso, degli errori che lo consolidano e degli strumenti che possono alleggerirlo. Hai riconosciuto — forse — uno o più degli scenari descritti.

## Cosa hai imparato in questa guida

### 01 Esiste un meccanismo preciso

Ansia e risposta sessuale sono fisiologicamente incompatibili: l'una attiva il simpatico, l'altra richiede il parasimpatico. Il ciclo ansioso è autosostenuto — ma si può interrompere. Capire questo cambia il modo in cui ti vedi.

### 02 Capire non basta: serve un percorso

Lavorare solo sugli esercizi non è sufficiente. Certi pattern neurali richiedono un lavoro profondo, guidato, personalizzato. Riconoscere questo non è debolezza — è il punto di partenza corretto.

*Il cervello cambia attraverso l'esperienza ripetuta, guidata, in un contesto sicuro — non attraverso la comprensione intellettuale da soli. Questa guida è un punto di partenza, non un percorso.*



*Il cervello non è fisso: ogni esperienza ripetuta scolpisce nuovi pattern al posto dei vecchi.*

## **Chi sono**

### **Dott.ssa Claudia Sposini**

#### **Psicoterapeuta e Consulente Sessuale**

Psicoterapeuta specializzata nei disturbi sessuali maschili. Il mio approccio integra psicoterapia e tecniche validate dalla ricerca clinica — terapia cognitivo-comportamentale, sensate focus e lavoro sul sistema nervoso autonomo — in un contesto professionale rigoroso e privo di giudizio.

Se quello che hai letto ti ha riconosciuto — se hai trovato qui la spiegazione che cercavi — il passo successivo è nella pagina che segue.

IL PASSO SUCCESSIVO

*Se quello che hai letto ti ha riconosciuto,  
il passo successivo è semplice.*

**PRENOTA UNA CONSULENZA**

• Scrivimi su WhatsApp • Rispondo personalmente

**Dott.ssa Claudia Sposini**

Psicoterapeuta e Consulente Sessuale

**WhatsApp: +39 338 250 8170**

*"Il silenzio non risolve nulla. La chiarezza, sì."*

— Dott.ssa Claudia Sposini

Guida ad uso personale — non sostituisce la consulenza clinica individuale

Copyright 2025 Dott.ssa Claudia Sposini — Vietata la riproduzione o distribuzione, totale o parziale, senza autorizzazione scritta.